Gabarito Discursivo — Esquemas por Tema

"Se a questão for sobre X, faça Y" — frases e estruturas de alto impacto para a correção IADES

SUS E POLÍTICAS

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Políticas Públicas de Saúde / Reforma Sanitária / Constituição e Saúde

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A Constituição Federal de 1988 rompeu com o modelo previdenciário excludente e consagrou a saúde como direito de todos e dever do Estado, financiado com recursos da seguridade social."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- Citar CF/88 art. 196: "saúde é direito de todos e dever do Estado"
- Mencionar 8ª Conferência Nacional de Saúde (1986) como marco da Reforma Sanitária
- Destacar o conceito ampliado de saúde: determinantes sociais (renda, educação, saneamento)
- Citar Lei 8.080/1990 (LOS) e Lei 8.142/1990 (participação social e financiamento)
- Relacionar com o avanço sobre o modelo Inamps (acesso restrito a trabalhadores formais)

MNEMÔNICO

`CF → LOS (8.080) → PARTICIPAÇÃO (8.142)`

CITE SEMPRE

CF/88 art. 196

SUS E POLÍTICAS

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Princípios do SUS / Universalidade / Equidade / Integralidade / Descentralização

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"Universalidade é direito, equidade é justiça, integralidade é totalidade — os três princípios doutrinários que, operacionalizados pela descentralização, regionalização e participação social, estruturam o SUS."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- DOUTRINÁRIOS: Universalidade (todos), Equidade ("tratar desigualmente os desiguais"), Integralidade (promoção → reabilitação)
- ORGANIZACIONAIS: Descentralização (municipalização), Regionalização/Hierarquiza Participação Social
- Relacionar equidade com Rawls ou simplesmente: quem mais precisa, mais recebe
- Mencionar Conselhos e Conferências de Saúde como instrumentos de participação social
- Aplicar pelo menos um princípio à vigilância sanitária (universalidade = proteção a todos; equidade = prioridade a vulneráveis)

Lei 8.080/1990

Lei 8.142/1990

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Diferenciar o modelo anterior (INAMPS — só segurado) do SUS (universal). Essa ruptura histórica é o argumento central que mais vale pontos.

MNEMÔNICO

UEI + DRP → "Uei, deu errado? Depende de Participação!"

CITE SEMPRE

Lei 8.080/1990 arts. 7º e 8º

CF/88 art. 198

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Nunca confunda princípios DOUTRINÁRIOS (UEI) com ORGANIZACIONAIS (DRP). Corrector vai riscar se você inverter.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Vigilância em Saúde / Componentes / VE / VISA / VSAS / VST

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A vigilância em saúde é processo contínuo e sistemático de coleta, análise e disseminação de informações sobre eventos de saúde, integrando quatro componentes complementares que atuam de forma articulada."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- VE — Vigilância Epidemiológica: monitora doenças/agravos, notificação compulsória, investigação de surtos
- VISA — Vigilância Sanitária: controla riscos em produtos, serviços e ambientes via poder de polícia
- VSAS — Vigilância em Saúde Ambiental: monitora água, ar, solo, desastres e contaminantes químicos
- VST — Vigilância em Saúde do Trabalhador: identifica e controla riscos ocupacionais
- Mencionar PNVS (CNS Resolução 588/2018) como marco normativo integrador

MNEMÔNICO

SNVS E ANVISA

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: SNVS / ANVISA / Regulação Sanitária / Lei 9.782/1999

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A ANVISA, autarquia sob regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, criada pela Lei 9.782/1999, coordena o SNVS e protege a saúde da população por meio do controle sanitário de produtos e serviços."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- ANVISA = autarquia sob regime especial (≠ Ministério da Saúde — é vinculada, não é o mesmo)
- Competências exclusivas da ANVISA: registro de medicamentos, controle em portos/aeroportos/fronteiras normatização nacional
- SNVS = ANVISA + vigilâncias estaduais + vigilâncias municipais + laboratórios (LACEN)
- Articulação via CIT (tripartite) e CIB (bipartite estadual)
- Estados = referência técnica regional + capacitação municipal + laboratórios regionais

MNEMÔNICO

`ANVISA = A Nação VIgIA Sanitariamente → autarquia, regime especial, vinculada ao MS`

ESTA: Epidemiológica, Sanitária, Trabalhador, Ambiental

CITE SEMPRE

Lei 8.080/1990

CNS Resolução nº 588/2018 (PN

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Nunca omita a VST (Saúde do Trabalhador) — é o componente mais esquecido e o que mais surpreende o corrector.

CITE SEMPRE

Lei 9.782/1999

Lei 8.080/1990

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

ANVISA ≠ Ministério da Saúde. ANVISA é autarquia VINCULADA ao MS. MS formula políticas; ANVISA regula e fiscaliza. Confundir os dois é erro grave.

PODER DE POLÍCIA

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Poder de Polícia / Atributos / Fiscalização / Autuação / Fundamento Jurídico

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"O poder de polícia administrativa, positivado no art. 78 do CTN, confere ao Estado o direito de limitar direitos individuais em prol da saúde coletiva, exercido mediante discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Discricionariedade: fiscal avalia conveniência/oportunidade dentro dos limites legais

Autoexecutoriedade: administração executa diretamente (ex.: apreensão) sem prévia autorização judicial

Coercibilidade: imposição independente da anuência do particular

Requisitos de validade do ato: COMPETÊNCIA, FORMA, OBJETO, MOTIVO e FINALIDADE

Princípio da proporcionalidade: a medida deve ser adequada à gravidade da irregularidade

MNEMÔNICO

DAC = Discricionariedade,

PODER DE POLÍCIA

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Auto de Infração / Interdição / Apreensão / Medidas Cautelares / Processo Administrativo Sanitário

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A lavratura do auto de infração inaugura o processo administrativo sanitário e assegura ao autuado o contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais que não são afastadas pela urgência sanitária."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Medidas cautelares (preventivas): independem de processo prévio, aplicadas em risco iminente

Auto de Infração: deve conter fatos, enquadramento legal, dados do autuado e assinatura do fiscal

Fluxo PAS: Auto → Defesa prévia (prazo legal) → Julgamento → Recurso administrativo

Interdição cautelar ≠ interdição definitiva (cautelar = medida imediata; definitiva = penalidade após PAS)

Penalidades da Lei 6.437/1977: advertência → multa → apreensão → interdição → cancelamento de licença

MNEMÔNICO

```
Autoexecutoriedade,
Coercibilidade |
COMOFIMOB =
Competência, Forma,
Finalidade, Objeto,
Motivo
```

CITE SEMPRE

- CTN art. 78
- Lei 6.437/1977
- CF/88 art. 37

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Sempre mencionar que o poder de polícia tem LIMITES — não é arbitrário. A legalidade, proporcionalidade e o devido processo legal o contêm.

```
AUTO → DEFESA →
JULGA → RECURSA
(fluxo do PAS)
```

CITE SEMPRE

- Lei 6.437/1977
- Lei 16.140/2007 (GO)
- Lei 13.800/2001 (GO)
- CF/88 art. 5º, LV

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Interdição cautelar é medida acautelatória (risco iminente) e NÃO é punição. A punição definitiva vem depois do PAS. Confundir os dois é erro conceitual grave.

ÉTICA E CONDUTA

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Ética do Servidor / Conduta do Fiscal de Vigilância Sanitária / Decreto 9.837/2021 / Portaria 170/2018

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"O Fiscal de Vigilância Sanitária, além das normas gerais de conduta do servidor público, sujeita-se a código de ética específico que privilegia a imparcialidade, a transparência, a eficiência e a primazia do interesse público."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Decreto 9.837/2021: código de ética geral dos servidores do Executivo estadual de GO

Portaria SES 170/2018: código de ética específico do Fiscal de Vigilância Sanitária

Princípios centrais: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência (art. 37 CF)

Conflito de interesses: fiscal deve se declarar impedido em situações de interesse pessoal

Responsabilidade: esferas administrativa, civil e penal são independentes e cumuláveis

MNEMÔNICO

LEGISLAÇÃO GO

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Lei 16.140/2007 / Sistema de Vigilância em Saúde em Goiás / SVS-GO / Competências Estaduais

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A Lei 16.140/2007 insere Goiás no federalismo sanitário, atribuindo à Superintendência de Vigilância em Saúde da SES-GO a coordenação das ações de proteção à saúde, em articulação com a ANVISA e os municípios goianos."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Estado coordena, normatiza e presta cooperação técnica; municípios executam no âmbito local

SVS-GO = órgão coordenador do sistema estadual de vigilância em saúde

Instrumentos: licença sanitária, auto de infração, interdição, apreensão, termo de visita

PAS estadual: regido pela Lei 13.800/2001 (processo administrativo GO)

Articulação via CIB-GO (Comissão Intergestores Bipartite de Goiás)

MNEMÔNICO

`GO: SVS coordena → MUNICÍPIOS executam → CIB-GO pactuação`

```
LIMPE = Legalidade,
Impessoalidade,
Moralidade,
Publicidade,
Eficiência
```

CITE SEMPRE

Decreto 9.837/2021

Portaria SES-GO nº 170/2018

CF/88 art. 37 (LIMPE)

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Mencionar que o fiscal tem FÉ PÚBLICA em suas constatações — o auto de infração presume-se verdadeiro até prova em contrário. Esse detalhe vale pontos extras.

CITE SEMPRE

Lei estadual 16.140/2007

Lei 13.800/2001

CIB-GO

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Sempre citar a SVS-GO (Superintendência de Vigilância em Saúde) como órgão coordenador estadual. Omitir essa especificidade goiana é perder pontos de localização contextual.

LEGISLAÇÃO GO

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Processo Administrativo / Princípios / Contraditório / Ampla Defesa / Lei 13.800/2001

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A Lei 13.800/2001 regula o processo administrativo em Goiás e garante ao administrado o contraditório, a ampla defesa, a motivação das decisões e o direito a recurso, como expressões inafastáveis do Estado Democrático de Direito."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Princípios: legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, contraditório, segurança jurídica

Direito à ampla defesa: prazo para apresentação de defesa prévia e produção de provas

Motivação obrigatória: toda decisão administrativa deve ser fundamentada

Recursos: efeito suspensivo somente quando expressamente previsto

Decadência e prescrição: prazo para a Administração exercer o poder punitivo

MNEMÔNICO

MEDICAMENTOS E FARMÁCIAS

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Medicamentos / Registro / Licença Sanitária / Fabricação / Lei 6.360/1976 / Decreto 8.077/2013

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"Nenhum medicamento pode ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de registrado no órgão de vigilância sanitária competente, sendo o registro condição legal de acesso ao mercado."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Lei 6.360/1976 art. 12: proibição absoluta de comercializar produto sem registro válido na ANVISA

Decreto 8.077/2013: regula condições de funcionamento e licenciamento das empresas do setor

Produto com registro VENCIDO ≠ produto com prazo de VALIDADE vencido (são conceitos distintos!)

Medicamento sem registro = produto FALSIFICADO ou CONTRABANDEADO — comunicação à Polícia

Boas Práticas de Fabricação (BPF) como pré-requisito para concessão de licença

CONTRADITÓRIO + AMPLA DEFESA + MOTIVAÇÃO = tríade do PAS democrático

CITE SEMPRE

Lei 13.800/2001

CF/88 art. 5º, LIV (devido proces

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

O processo administrativo sanitário em GO obedece à Lei 13.800/2001 subsidiariamente. Citar essa lei, além da Lei 6.437/1977, demonstra conhecimento específico do ordenamento estadual.

MNEMÔNICO

REGISTRO = permissão de mercado | VALIDADE = prazo de uso → DIFERENTES

CITE SEMPRE

Lei 6.360/1976 art. 12

Decreto 8.077/2013

RDC 301/2019 (BPF)

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Diferenciar REGISTRO (autorização da ANVISA para colocar no mercado) de VALIDADE (prazo de uso do produto). Confundir os dois é erro conceitual eliminatório.

MEDICAMENTOS E FARMÁCIAS

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Farmácia / Drogaria / Responsável Técnico / Dispensação / Controlados / Lei 5.991/1973

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A presença do farmacêutico responsável técnico durante todo o horário de funcionamento é exigência legal inafastável — não há exceção para refeições, consultas ou ausências momentâneas."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Lei 5.991/1973 art. 15: farmacêutico deve estar presente em TODO o horário de funcionamento

Portaria SVS/MS 344/1998: regula medicamentos controlados (armazenamento em armário fechado com chave, escrituração, retenção de receita)

RDC 20/2011: antimicrobianos exigem retenção de receita médica

Responsabilização dupla: estabelecimento perante VISA + farmacêutico RT perante CRF-GO

Comunicação ao CRF-GO é recomendável quando há infração do RT

MNEMÔNICO

ALIMENTOS

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Alimentos / DTA / Surto Alimentar / Boas Práticas em Alimentos / RDC 216 / RDC 275 / Decreto-Lei 986/1969

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA) representam grave problema de saúde pública, prevenível mediante adoção das boas práticas regulamentadas pela RDC 216/2004 em serviços de alimentação e pela RDC 275/2002 na indústria."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

RDC 216/2004: boas práticas em SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (restaurantes, lanchonetes, cantinas)

RDC 275/2002: POPs (Procedimentos Operacionais Padronizados) para INDÚSTRIAS de alimentos

DL 986/1969: normas básicas sobre alimentos — proibição de alimentos alterados, falsificados, deteriorados

Temperatura crítica: alimentos quentes > 60°C; frios < 5°C — faixa de risco: 5°C a 60°C

Surto de DTA: articulação VISA (inspeciona estabelecimento) + VE (investiga casos) +

```
RT: TODO o horário,
SEM exceção → Lei
5.991/1973
```

CITE SEMPRE

- Lei 5.991/1973
- Portaria 344/1998
- RDC 20/2011 (antimicrobianos)
- RDC 44/2009

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Quando o proprietário alegar que o farmacêutico "saiu para almoço": a Lei 5.991/1973 não admite essa exceção. O corrector vai valorizar muito a refutação fundamentada.

LACEN-GO (análise laboratorial)

MNEMÔNICO

```
DTA: 60°C quente |
5°C frio | 5-60°C =
ZONA DE PERIGO
```

CITE SEMPRE

- RDC 216/2004
- RDC 275/2002
- Decreto-Lei 986/1969

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Em casos de surto alimentar, mencionar CADEIA DE CUSTÓDIA das amostras e LACEN-GO como laboratório de referência. Esses dois termos têm alto poder de pontuação.

QUALIDADE E BPF

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: APPCC / HACCP / Pontos Críticos de Controle / Análise de Perigos / Segurança de Alimentos

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"O APPCC é sistema preventivo de base científica que identifica perigos específicos e define medidas preventivas para seu controle, garantindo a inocuidade alimentar ao longo de todo o processo produtivo."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

7 PRINCÍPIOS: 1-Análise de perigos; 2-Identificação dos PCCs; 3-Limites críticos; 4-Monitoramento; 5-Ações corretivas; 6-Verificação; 7-Documentação

APPCC é PREVENTIVO (≠ inspeção do produto final, que é reativo)

Pré-requisitos obrigatórios: BPF e POPs devem estar implementados ANTES do APPCC

Árvorede decisão: ferramenta para identificar se um ponto do processo é ou não PCC

Base legal: Codex Alimentarius + RDC 275/2002 + exigências da indústria exportadora

MNEMÔNICO

QUALIDADE E BPF

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Boas Práticas de Fabricação / BPF / Gestão da Qualidade / Validação / Desvio de Qualidade

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"As Boas Práticas de Fabricação garantem que os produtos sejam consistentemente produzidos e controlados conforme padrões de qualidade adequados ao uso pretendido e às especificações do registro."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

BPF abrange: instalações, equipamentos, pessoal, documentação, controle de qualidade, armazenamento e distribuição

Sistema de Qualidade Farmacêutica (SQF): engloba BPF, revisão periódica de produtos e gestão de riscos

Validação: prove documentalmente que processo/método/equipame produz resultados consistentes

Plano Mestre de Validação (PMV): documento que define escopo, responsabilidades e cronograma de validações

Desvio de qualidade: qualquer não conformidade que pode impactar a segurança,

7P-APPCC: Perigos, PCCs, Parâmetros, Procedimento-monitoramento, Providências, Prova-verificação, Paper-documentação

CITE SEMPRE

RDC 275/2002

Codex Alimentarius

Portaria MS 1.428/1993

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

A diferença entre PONTO DE CONTROLE (PC) e PONTO CRÍTICO DE CONTROLE (PCC): no PCC, o perigo não é eliminado em etapa posterior — é a última barreira.

identidade, força, qualidade ou pureza do produto

MNEMÔNICO

BPF → VALIDA → DOCUMENTA → NOTIFICA

desvio → RASTREIA recall

CITE SEMPRE

RDC 301/2019 (BPF medicamen

RDC 658/2022

ICH Q10 (sistema de qualidade)

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Desvio de qualidade DEVE ser notificado à ANVISA quando há risco de dano ao consumidor (recall). A omissão é infração grave prevista na Lei 6.360/1976.

SAÚDE DO TRABALHADOR

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Saúde do Trabalhador / VST / Riscos Ocupacionais / Notificação Compulsória / Decreto 6.906/2009

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A vigilância em saúde do trabalhador articula saúde, trabalho e previdência para identificar, avaliar e controlar riscos ocupacionais, sendo a notificação compulsória de agravos instrumento central de monitoramento."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- Decreto estadual GO 6.906/2009: regulamenta competências da SES-GO em saúde do trabalhador
- Portaria 34/2006 (GO): lista de agravos de notificação compulsória em saúde do trabalhador no estado
- Agravos notificáveis: acidente de trabalho grave/fatal, intoxicação exógena, LER/DORT, pneumoconioses, entre outros
- Notificação via SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação)
- Nexo técnico epidemiológico: presunção de relação causal acidente-trabalho (NTEP)

MNEMÔNICO

SEGURANÇA DO PACIENTE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Segurança do Paciente / IRAS / Infecção Hospitalar / CCIH / Cultura de Segurança

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"Segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado, exigindo protocolos baseados em evidências, cultura institucional de não punição ao erro e vigilância ativa das IRAS."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- RDC 36/2013: institui ações de segurança do paciente em serviços de saúde — Núcleo de Segurança (NSP)
- CCIH (Comissão de Controle de Infecção Hospitalar): obrigatória em hospitais — Portaria MS 2.616/1998
- IRAS incluem: pneumonias associadas à ventilação (PAV), infecção de corrente sanguínea (ICS), ITU associada a cateter
- Higienização das mãos: medida número 1 de prevenção de IRAS, custo-benefício incomparável
- Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP): Portaria MS 529/2013 — 6 metas internacionais

```
VST: IDENTIFICA
risco → NOTIFICA via
SINAN → INVESTIGA
nexo → PROPÕE medida
```

CITE SEMPRE

- Decreto GO 6.906/2009
- Portaria GO 34/2006
- Lei 8.080/1990 art. 6º

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Citar SINAN como sistema de registro e o NTEP (nexo técnico epidemiológico) ao discutir relação causal. Esses termos específicos elevam a pontuação em ER.

MNEMÔNICO

```
NSP = Núcleo de
Segurança do
Paciente
(obrigatório por RDC
36/2013)
```

CITE SEMPRE

- RDC 36/2013
- Portaria MS 529/2013 (PNSP)
- Portaria MS 2.616/1998 (CCIH)

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Citar as 6 metas internacionais de segurança do paciente (OMS/Joint Commission): identificação correta, comunicação eficaz, medicação segura, cirurgia segura, higiene das mãos, prevenção de quedas.

RESÍDUOS E AMBIENTE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Resíduos de Serviços de Saúde / RSS / PGRSS / Grupos A B C D E / RDC 222/2018

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"O gerenciamento de RSS abrange, da geração à disposição final, responsabilidade inafastável do gerador, devendo o Plano de Gerenciamento (PGRSS) ser elaborado, aprovado e efetivamente executado como condição de funcionamento."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Grupo A (infectante): riscos biológicos — saco branco leitoso, símbolo biológico

Grupo B (químico): reagentes, drogas citostáticas, mercúrio — saco laranja ou recipiente específico

Grupo C (radioativo): rejeitos com radionuclídeos — símbolo de radiação ionizante, gerenciado com CNEN

Grupo D (comum): assimiláveis ao doméstico — saco preto/incolor

Grupo E (perfurocortante): agulhas, bisturis — caixa rígida amarela (até 2/3 da capacidade)

MNEMÔNICO

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Projetos Físicos de Estabelecimentos de Saúde / RDC 50/2002 / RDC 51/2011 / Habite-se Sanitário

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"Nenhum estabelecimento assistencial de saúde pode ser construído, reformado ou ampliado sem prévia aprovação do projeto físico pela VISA competente, sendo a RDC 50/2002 o instrumento técnico central dessa avaliação."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

RDC 50/2002: regulamento técnico para elaboração e avaliação de projetos físicos de EAS

RDC 51/2011: define requisitos mínimos para análise e aprovação de projetos físicos no âmbito do SNVS

Habite-se sanitário: documento de aprovação emitido pela VISA após vistoria do EAS construído

Áreas de um EAS: Ambulatorial, Internação, Apoio ao Diagnóstico, Apoio Técnico, Apoio Logístico

Competência de aprovação: VISA municipal (via CIB) ou VISA estadual conforme complexidade

ABCDE: Agente-bio, Bioquímico, Cancerígeno/radio, Doméstico, Espinho(cortante)

CITE SEMPRE

RDC 222/2018 (ANVISA)

CONAMA 358/2005

NR 32 (saúde do trabalhador)

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Caixas de perfurocortante (Grupo E) nunca podem ultrapassar 2/3 da capacidade. Esse limite específico é muito cobrado e demonstra conhecimento técnico detalhado.

MNEMÔNICO

PROJETO → APROVAÇÃO VISA (RDC 50) → CONSTRUÇÃO → HABITE-SE VISA → LICENÇA SANITÁRIA

CITE SEMPRE

RDC 50/2002

RDC 51/2011

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Projetos físicos de EAS passam por duas aprovações: 1ª pelo Corpo de Bombeiros (AVCB) e 2ª pela VISA (habite-se sanitário). São instâncias distintas e sequenciais.

SEGURANÇA DO PACIENTE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Esterilização de Materiais / CME / Métodos de Esterilização / Indicadores Biológicos

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A esterilização é o processo que elimina todos os microrganismos viáveis, incluindo esporos bacterianos, sendo sua eficácia comprovada por indicadores biológicos e monitorada por sistema de rastreabilidade."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Classificação de Spaulding: CRÍTICO (penetra tecido estéril → esteriliza), SEMI-CRÍTICO (mucosa → no mínimo desinfecção alto nível), NÃO CRÍTICO (pele íntegra → limpeza/desinfecção baixo nível)

Métodos: autoclave (vapor saturado 121°C/134°C), óxido de etileno (EtO), peróxido de hidrogênio plasma, glutaraldeído (alto nível)

Indicadores: FÍSICO (temperatura/pressão), QUÍMICO (muda cor), BIOLÓGICO (esporo Geobacillus stearothermophilus) — biológico é o MAIS confiável

CME (Central de Material e Esterilização): unidade

RESÍDUOS E AMBIENTE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Segurança Radiológica / Radiação Ionizante / Proteção Radiológica / CNEN

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A proteção radiológica visa minimizar a exposição à radiação ionizante, orientada pelos princípios de justificação, otimização e limitação de doses, sob regulação conjunta da CNEN e da ANVISA."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

Três princípios da proteção radiológica: JUSTIFICAÇÃO (o benefício supera o risco), OTIMIZAÇÃO (manter exposição tão baixa quanto razoável — ALARA), LIMITAÇÃO (limites de dose para trabalhadores e público)

ALARA: As Low As Reasonably Achievable — princípio-guia da proteção radiológica

Trabalhador com exposição ocupacional: limite de 20 mSv/ano (média de 5 anos)

Raios-X: exige alvará de funcionamento da CNEN + licença da VISA estadual

EPIs: avental plumbífero, protetor de tireoide, óculos plumbíferos; dosímetro individual obrigatório

obrigatória em hospitais, regida por RDC 15/2012 e RDC 330/2019

Rastreabilidade: todo material processado deve ser rastreável — lote de esterilização, data, responsável

MNEMÔNICO

`Spaulding: CRítico → ESteriliza | Semi → Desinfecta Alto Nível | Não-crítico → Limpa`

CITE SEMPRE

- RDC 15/2012
- RDC 330/2019
- Classificação de Spaulding

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

O indicador BIOLÓGICO é o único que valida diretamente a morte do microrganismo. Indicadores físico e químico são monitoramento, não validação. Essa distinção é cobrada.

MNEMÔNICO

`ALARA: Tão Baixo Quanto Razoavelmente Possível → JUSTIFICA → OTIMIZA → LIMITA doses`

CITE SEMPRE

- CNEN NN 3.01 (proteção de trab
- RDC 330/2019
- Portaria SVS/MS 453/1998

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

A CNEN regula os aspectos nucleares/radiológicos; a ANVISA (e por delegação as VISAs estaduais) regula o licenciamento dos equipamentos em serviços de saúde. São competências complementares, não concorrentes.

ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Gerenciamento de Tecnologias em Saúde / Equipamentos Médicos / Tecnovigilância

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"A tecnovigilância monitora eventos adversos e queixas técnicas relacionados a produtos para a saúde pós-comercialização, subsidiando ações regulatórias da ANVISA para proteção dos usuários."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- Tecnovigilância = vigilância pós-mercado de equipamentos, materiais, implantes e artigos médico-hospitalares
- Notificação obrigatória à ANVISA: eventos adversos e queixas técnicas de produtos para saúde (RDC 67/2009)
- Ciclo de vida da tecnologia: avaliação → incorporação → monitoramento → desinvestimento
- Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS): evidências científicas para decisão de incorporação
- CONITEC: Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Lei 12.401/2011)

RESÍDUOS E AMBIENTE

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Abastecimento de Água / Potabilidade / Licenciamento de Água / Portaria SES-GO 2145/2024

FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)

"O controle da qualidade da água para consumo humano é ação prioritária de vigilância ambiental em saúde, regulada pela Portaria GM/MS 888/2021 e, no Estado de Goiás, pela Portaria SES-GO 2145/2024 para licenciamento dos prestadores de serviço de abastecimento."

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- Portaria SES-GO 2145/2024: regulamenta licenciamento sanitário de prestadores de abastecimento de água em GO
- Portaria GM/MS 888/2021: padrão de potabilidade nacional — substituiu a Portaria 2914/2011
- Vigilância da qualidade da água: responsabilidade das VISAs municipais e estadual
- Parâmetros controlados: microbiológicos (E. coli, coliformes totais), físico-químicos (turbidez, cloro residual), radioatividade

MNEMÔNICO

CONITEC → incorpora tecnologia no SUS com base em EVIDÊNCIAS (ATS)

CITE SEMPRE

RDC 67/2009 (tecnovigilância)

Lei 12.401/2011 (CONITEC)

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Distinguir HEMOVIGILÂNCIA (sangue e hemoderivados), FARMACOVIGILÂNCIA (medicamentos) e TECNOVIGILÂNCIA (equipamentos/materiais). A banca pode cobrar a distinção.

Plano de Amostragem: frequência e pontos de coleta definidos conforme população atendida

MNEMÔNICO

Água: POTABILIDADE (888/2021 federal) + LICENCIAMENTO GO (2145/2024 estadual)

CITE SEMPRE

Portaria SES-GO 2145/2024

Portaria GM/MS 888/2021

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Citar a Portaria SES-GO 2145/2024 demonstra conhecimento atualizado da legislação goiana específica — questões cobram a norma mais recente.

ÉTICA E CONDUTA

SE A QUESTÃO FOR SOBRE: Assédio Moral / Ambiente de Trabalho / Lei 18.456/2014 / Servidor Público

> ***FRASE-ÂNCORA (USE NA INTRODUÇÃO OU CONCLUSÃO)***
> ***"O assédio moral no serviço público é conduta vedada pela Lei estadual 18.456/2014 e configura infração disciplinar, podendo ensejar demissão, além de responsabilidade civil e penal do assediador."***

PONTOS OBRIGATÓRIOS NO TEXTO

- Conceito: exposição repetida e prolongada a condutas humilhantes, vexatórias ou constrangedoras
- Lei 18.456/2014 (GO): pune o assédio moral na Administração estadual com advertência, suspensão e demissão
- Assédio vertical descendente (chefe → subordinado) é o mais comum; horizontal (entre pares) também é punido
- Vítima deve documentar: datas, testemunhas, e-mails, mensagens — prova é essencial
- Chefia pode ser punida mesmo que assédio seja praticado por terceiro sem ação corretiva

MNEMÔNICO

```
Assédio = REPETIÇÃO
+ HUMILHAÇÃO +
INTENÇÃO → punição:
advertência →
suspensão → demissão
```

CITE SEMPRE

Lei estadual 18.456/2014

Decreto 9.837/2021 (ética servid

NÃO ESQUEÇA — PONTO MAIS COBRADO

Diferenciar assédio moral (conduta repetida e prolongada) de conflito ou estresse pontual do trabalho. A repetição e a intencionalidade são elementos caracterizadores do assédio.